

RODRIGO FERNANDO BERTOZZI	
ND:	APNEIA DO SONO
MEDICO:	
MEDICAMENTOS:	
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	
PA:	
OXIMETRIA:	

22/12 pcte retira a masc. durante a noite.

Fuga = 20.2/lv / IAH = 1.6/h.

m. de uso: 4h20' — lua

27/01 - pcte bem adaptado.

Fuga = 2.2/lv

IAH = 1.4/lv

m. de uso: 5h40' — lua

10/06 m. ~~de~~ 6h30'

21 P = 10 cmH₂O

IAH = 0.9

Fuga = 17.0 (melhora do quadro da apneia) — lua

10/08 m. de uso: 6h21

21 P = 10 cmH₂O

IAH = 0.9

lua

~~10/11~~ P = 10 cmH₂O

21 IAH = 1.6/lv

m. de uso: 6hs

TROCA DE FILTRO OK

lua.

~~18/01~~ P = 10

22 IAH = 1.7

m. de uso: 6h27'

Fuga: 6.6 l/min

— lua

~~28/08~~ P = 10 cmH₂O

22 IAH = 1.5/lv

m. de uso: 6h17'

Bem adaptado

Fuga = 8.1

lua

~~02/11~~ P = 10 cmH₂O

22 IAH = 1.1 e/lv

m. de uso: 6hs32'

18/01
23 P = 10 cm H₂O
Fuga = 6.4 l/min
IAH = 1.0
Em dieta p/ ↓ de peso.

Jue.

15/03
2023 P = 10 cm H₂O
fuga = 0.2 l/min
medic = 6 h 30'
IAH = 1.2
- Bem adaptado
- caminhada / Atividade física

16/03 P = 10 cm H₂O
IAH = 0.9 ele
m. de uso: 6h
↑ unisuf. p/ 6

Jue

15/08
23 P = 10 cm H₂O
IAH = 1.6 ele
m. de uso: 6h 8'
Bem adaptado, relata acordar prox. à 4hs.
da manhã.

Jue

31/10
23 P = 10 cm H₂O
IAH = 1.1
m. de uso: 6:16'
Fuga = 12.6
Bem adaptado, relata estar
fazendo ativi// física

Jue

16/01
24 P = 10 cm H₂O
IAH = 1.1 ele
m. de uso: 6h
Fuga = 7.4 l/min.
S/ queixas.

Jue claudia

12/04
24 P = 10 cm H₂O
IAH = 0.8 ele
m. de uso: 6h 27m
fuga: 7.3 l/min (percentil)
Dorme muito tarde
mantém atividade física
S/ queixas
Bem adaptado
Natacha

19/06/24 P = 10 cm H₂O
IAH = 1.0 ele
m. de uso: 6h 3m
fuga: 3.8 l/min (percentil)
Bem adaptado
Ainda c/ dificuldade de
regular horário p/ dormir
Mantém atividade física
Natacha

17/09/24 P=10cmH₂O

IAH=1.4 e/h

m. de uso: 5h 17'

Bem adaptado

Reforço higienização e troca de filtro

Nota: Nota

18/12/24

P=10cmH₂O

IAH=1.2 e/h cansado.

fuga=8.6 lpm - Dorme rápido, tr. acordando a noite.

- Pedi pl + o n.º de horas.
fuo.

11/03/25

P=10cmH₂O

IAH=0.8 e/h

m. de uso: 6h 40'

fuga=3.5 lpm.

Bem adaptado, sem queixas.

Está utilizando bem o CPAP. Oriento ir pl o urologista. — fuo.

Nome: RODRIGO FERNANDO BERTOZZI

Data de Nascimento: 13-6-1978

IMC: 32,14

Sexo: Masculino

Data do exame: 05-10-2020

Peso: 110 kg

Altura: 1,85 m

Médico: DR. MARIO SÉRGIO LEONE

CARREGOSA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 05-10-2020, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 472,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 54,5 e 101,5 minutos. O tempo total de sono foi de 472,6, eficiência de 79,0% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,6%; estágio N2: 62,4%; estágio N3: 16,9%; sono REM: 17,1%. O índice de despertares foi de 17,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 24,3, sendo elas 75 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 76 hipopnéias. A SpO2 média foi de 95% e mínima de 77%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 53 - 88 bpm e NREM de 50 - 86 bpm.

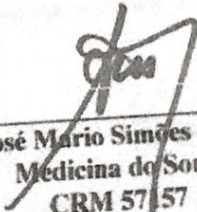
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (11), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latência para o sono aumentada;
4. aumento do número de despertares breves;
5. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (3,2/hora);
6. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 10 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: RODRIGO FERNANDO BERTOZZI

Data de Nascimento: 13-6-1978

IMC: 30,68

Sexo: Masculino

Data do exame: 17-02-2020

Peso: 105 kg

Altura: 1,85 m

Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE

CARREGOSA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 17-02-2020, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 530,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 130,0 e 112,5 minutos. O tempo total de sono foi de 375,5, eficiência de 70,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,7%; estágio N2: 59,0%; estágio N3: 17,2%; sono REM: 21,2%. O índice de despertares foi de 28,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 54,2, sendo elas 290 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 49 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e mínima de 76%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 48 - 81 bpm e NREM de 50 - 87 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (10), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 54,2/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=76%);
5. latência para o sono aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

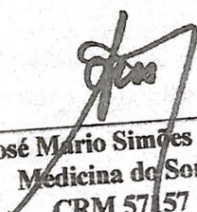
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157